جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نها محمد عبدالله --

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العياط **العنوان :** ----

رقم البطاقة : 27803152100288 **رقم التليفون :** 01119535358 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 15-03-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعة مقطعية مخ مع صبغة [10851] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------**قسم :** ----------

جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------

ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نها محمد عبدالله --
National ID: 27803152100288

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of the brain**.

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

09/22/2026

MDT FORM

Name:	نها محمد عبدالله عبدالباقى	**MRN:**	13261
Age:	49 Y	**ID:**	27803152100288
Menopausal Sta	regular	**Phone:***	01119535358
NRS SCORE:		**Marital Status:**	widow
BMI:		**Family History:**	+ve breast (mother ,aunt)
Gender			
CO Morbidity:	htn,dm	**Reason Of MDT:**	new
Surgical History:*	cardiac catheter on aspocid	**ECOG Performance Status**	○ 0 ◉ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: IDC G111

ER: 6/8 **PR:** 5/8 **HER2:** NOT amp **KI67:** 60%

History:

Sonomammography:
It UOQ lesion 2 oclock 37x30mm
multiple pathological level 1 23x17mm ,infraclavicular ln 16x10mm

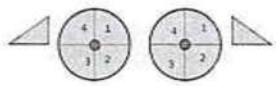
Biomarker/Molecular

Mets Workup:
ct :bulky uterus
paus :free

Recommendations:
For possibility of NACT after clip insertion then LT BCS +ALND

MDT Outcome & Plan
Portacath insertion
Clips insertion
NACT: 4 AC - 4 Docetaxel
LT BCS +ALND

R L



TNM

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:
T2 N3(Pathological LN +1Infraclav)M0

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
خالد عبد العزيز	د محمد تيراوي		

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

أ.د/ حســـــن الكيكى
أ.د/ محمد عبد اللطيف
د./ رانـــيـــا حـــمدى
د./ أيمـــن عبد الوهاب

مركز الجيزة للأشعة
GIZA SCAN

NAME: نهى محمد عبدالله	ID : 11210401
Prof.Dr : ---- --	Date : 13/09/2026

Pelvic & trans-vaginal ultrasonographic examination revealed: -

- Normal appearance of the uterus measuring 10.4x6 x6.5 cm, with homogenous myometrium and intact endometrial lining measures 8 mm. No focal lesion.
- Normal size and echopattern of both ovaries, no masses no abnormal cysts.
  The right ovary = 2.5 x1.8 cm.
  The left ovary = 2.7 x1.7 cm.
- Normal appearance of the urinary bladder.
- No adnexal masses.
- No pelvic collection or pelvic masses.

Conclusion:

- Normal study.

Truly yours
Dr. Mohamed Badawy, MSc

٥ ش مراد - ميدان الجيزة تليفاكس : ٣٧٧٤٦٠٣٠ - ٣٧٧٤٦٠٣١ - ٣٥٦٨٨٩٥٤ موبايل: ٠١١٤٠٧٧٢٢٦٨
E-mail:giza.scan@yahoo.com

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

جوستاف روسي

Patient's Name:	**Noha Mohammed Abdallah**
Date:	**2026-07-13**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 48-year-old female with left palpable lump

Findings:

left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, middle third irregular high density mass lesion
- **Ultrasound** demonstrated 2o'clock, middle third, 10 cm from nipple, 5 mm deep to the skin, irregular heterogenous hypoechoic solid mass lesion with, posterior acoustic shadowing and internal vascularity on color Doppler study measuring 37x30 mm.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Multiple patlgical lymph nodes .largest level I measures 23x17mm ,level II measuring 10X5MM ,infra clavicualr measuring 16x10mm

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- ***Left breast (BIRADS 5): Malignant looking lesion for biopsy***
- ***Right breast (BIRADS 1): Normal study.***

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

Mammogram

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

جوستاف روسي

Patient Name	نها محمد عبد الله	**Case No.**	**341824**
Sex/Age	**Female 48 Y**	**Patient No.**	**24733**
Registered Date	**13/7/2026 02:08:58 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**11/8/2026 02:55:42 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**15/8/2026 11:54:12 AM**	**Pathology No.**	**2201/26**

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 13/07/2026, at 9:55 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
-Four grey, white tissue cores, the largest one measured 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9) & SISH.

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Absent.
- Necrosis: Focal.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Marked.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 25% of tumor cells (score 6/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Not amplified. (Average Her2 copy No.: (2.3), Her2/CEP17 ratio: (1.39)).
- Ki67%: 60%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 3.
IPT:
- ER: Positive (score 6/8).

GUSTAVE ROUSSY
Gustave Roussy International Hospital Pathology Lab
جوستاف روسي

Patient Name	نها محمد عبد الله	**Case No.**	**341824**
Sex/Age	**Female 48 Y**	**Patient No.**	**24733**
Registered Date	**13/7/2026 02:08:58 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**11/8/2026 02:55:42 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**15/8/2026 11:54:12 AM**	**Pathology No.**	**2201/26**

- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Not amplified, Group V. (Average Her2 copy No.: (2.3), Her2/CEP17 ratio: (1.39)).
- Ki67%: 60%.

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** *Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.
ISH groups:
The ratio is calculated and the results is interpreted as:
• Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
• Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
• Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
• Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).
• Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Fatth Islamic Center

C.T. - M.R.I

U.S. - Duppler - E.C.G. Stress

E.E.G - E.M.G - Mamm - Eye Unit

الجمعية الشرعية

مركز الفتح الإسلامى

أشعة مقطعية بالكمبيوتر - الرنين المغناطيسى
موجات صوتية - دوبلر ملون - رسم قلب بالمجهود
رسم مخ - رسم عضلات - فحص ثدى - وحدة عيون

اسم المريض : نهى محمد عبد الله التاريخ : ٢٠٢٦/٨/٢٧

C.T. REPORT

Multislice CT scan examination was done for the **Chest, Abdomen & Pelvis**

Multiplanner reconstruction images were obtained ***following*** I.V. contrast enhancement and gut opacification with Telebrix

with special ***triphasic*** helical scanning of the liver

I - Chest:

- *Left breast outer quadrant heterogeneous soft tissue lesion is seen with prominent left axillary L.Ns*
- *Clear both lung fields with no evidence of focal pulmonary infiltration or masses.*
- *No evidence of pleural or pericardial sac collection*
- *No hilar or mediastinal lymph nodes enlargement.*
- *Normal C.T. appearance of the heart and its great vessels.*

II - Abdomen & Pelvis:

- *The liver is mild enlarged with diffuse hypodense parenchyma denoting fatty changes , however, no obvious focal mass lesion or dilated biliary radicle.*
- *The spleen, and retroperitoneal structures including the kidneys, adrenal glands and pancreas are within normal limits, with no obvious mass lesion or significant lymph node enlargement.*
- *The opacified bowel loops including the stomach are regularly filled, with no obvious mass lesion or significant mural thickening.*
- *No ascites or pelvic collections seen.*
- *Bulky uterus is also seen .*
- *Left ovarian small cysts about 2cm is also seen.*
- *Normal C.T. appearance of the urinary bladder.*

Impression:

- ***Left breast mass with prominent left axillary L.Ns for further workup .***
- ***Fatty liver changes , No focal lesion .***
- ***Bulky uterus for pelvic U/S comution***
- ***Left ovarian simple cyst.***

Dr. Ahmed El-Deeb, MD.

aa

٥٣ شارع ١٠ بالمعادى ت : ٢٣٥٨٧٣٣٢ - ٢٣٥٨٥٨١٩ - ٠١١٠٠١٥١٣٨٠ - ٠١٠٢٨٤٨٣٦٩٥

CT Scan
[redacted]_SCAN